

NSYH550A*227390099

ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Prof. Técnico

SINTOMAS/ QUEIXA

Sonolência diurna / cansaço / mm II edema

MEDICAMENTOS

Glibenclamide XR (2x) / Glyxambi (1x) / Aesc-HCT

HAS / DM / Colesterol / Stangit / Basileto / Crestor

HORA QUE DORME:

21:30

HORA QUE ACORDA:

9h

Aloprinol

BANHEIRO

3 - 4x

Concor / Anadol / Fivale / Novelin N.

TIPO DE RESPIRAÇÃO

respirador oral

EXERCÍCIO FÍSICO

fisioterapia

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: 5

ALMOÇO: 5

LANCHE: 5

JANTAR: 20

PESO: 100

ALTURA: 170

IAH: 59.5

MALLAMPATI: IV

SPO2: 73%

25/05/23 Adaptação CPAP.

DR. Marcelo

31/05 Relato de dificuldade p/ dormir e
23 respirar pelo nariz15/06 P = 10.2 cmH₂O

23 IAH = 9.4 e/eV

M. de uso = 7h 24'

Relata melhora do cansaço ao esforço

06/07 P = 10.5 cmH₂O

23 IAH = 15.8 e/eV

M. de uso: 7h

1x ao banheiro

Umidade 0

21/07 P = 10.5 cmH₂O

23 IAH = 10 e/eV

M. de uso: 6h

Umidade 3

18/08 P = 10.4 cmH₂O

23 IAH = 12.2 e/eV

M. de uso: 6h 25'

Fuga = 98 l/min.

Relata que está rouco devido o uso do "CPAP" indica o otorrinolaringologista.

09/10 P = 10.4 cmH₂O

23 IAH = 5.5 e/eV

M. de uso: 6h 11'

ajuste a máscara.

04/12 P = 10.5 cmH₂O

23 IAH = 13.8 (IC = 0 / IA = 3.3 / IH = 10.4).

M. de uso: 6h 15'

Fuga = 0.8 l/min.

17/01 P = 12 cmH₂O inicial 6.5

24 IAH = 11.

M. de uso: 6h

17/04 P = 12 cmH₂O

24 IAH = 12.3 e/eV

M. de uso: 6h 32'

Fuga = 1.2 l/min.

ajuste o CPAP.

12/06
24

$P = 12.5 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{Fuga} = 0.5 \text{ lpm}$
 $\text{IAH} = 1.9 \text{ el/h}$

Jua.

14/08
24

$P = 12.5 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 7.6 \text{ el/h}$
 $\text{Fuga} = 0.7 \text{ lpm}$

Jua. Lúcio

17/09
24

$P = 12.5$
 $\text{IAH} = 8.3$
 $\text{fuga} = 1.4 \text{ l/m}$

Natasha

16/10
24

$P = 12.5 \text{ cm H}_2\text{O}$
 $\text{IAH} = 7.3 \text{ el/h}$ * parece que dorme alguns dias de
m. de uso: fhs barreira pl cima.

Jua.

14/02/25 $P = 12.5 \text{ cm H}_2\text{O}$

$\text{IAH} = 10 \text{ el/h}$
m de uso: 7h 08'
 $\text{fuga} = 4 \text{ l/m}$

Oriento posição na
hora de dormir e higiene
da máscara.

Natasha

13/03/25 $P = 12.5 \text{ cm H}_2\text{O}$

$\text{IAH} = 5.1 \text{ el/h}$
m de uso: 6h 53'
 $\text{fuga} = 9.7 \text{ l/m}$

Bem adaptado
Não usou alguns dias
devido problema dentário

Natasha

29/05/25 $P = 12.4 \text{ cm H}_2\text{O}$

$\text{IAH} = 10.6 \text{ el/h}$
m de uso: 7h 21'
 $\text{fuga} = 2.2 \text{ l/m}$

Oriento dormir de lado

Natasha

Nome: ANTONIO CARLOS DE SOUZA

Data de Nascimento: 21-5-1951

IMC: 35,99

Sexo: Masculino

Data do exame: 15-04-2023

Peso: 104 kg

Altura: 1,70 m

Médico: DR. MARCELO JOSE M. N. DE

ASSIS

Medicamentos:

Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 15-04-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 500,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 178,0 e 184,0 minutos. O tempo total de sono foi de 228,0 min, eficiência de 45,6% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 2,9%; estágio N2: 63,4%; estágio N3: 14,5%; sono REM: 19,3%. O índice de despertares foi de 20,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 59,5/hora, sendo 52 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 61 hipopnéias. A SpO2 média foi de 89% e a mínima de 73%, permanecendo 52,1% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 55 - 80 bpm e NREM de 55 - 84 bpm.

CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (3), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM diminuída e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 59,5/hora; *normal até 5 e 10*
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=73%); *↑ 77%*
5. latências para o sono prolongadas;
6. aumento do número de despertares breves;
7. registro de ronco durante o sono.

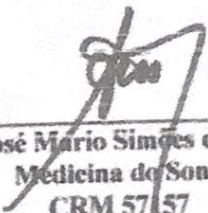
Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono e dessaturação de graus acentuados.

IAH: 05-15 /hora leve.

IAH: 15-30 /hora moderada.

IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57157